

Datos Personales							
Nombre:	CARLOS MARIO CASTAÑEDA MARTINEZ	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	1993-04-03	Edad	32 Años, 10 Meses, Y 14 Días
Identificación:	CC - 1063962211	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	UnionLibre	Ocupación:	MEDICO INTERNISTA
Correo Electrónico:	Cm_carlosmario@hotmail.Com - 1063962211			Dirección:	Calle 13 Nro 24-01 Bosconia César		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		PIERANGIELLYS PABON-PAREJA - Parentesco (otro) - Teléfono (3012793293)					

Apertura psicología del 2026-01-27 12:30:30: 32 años, 10 meses, y 14 días

DATOS GENERALES

Remisión

PARTICULAR

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere el paciente, “ludopatía, inicie con 5 mil pesos, pero a partir del año pasado ya eran 500, 600, apostaba a equipos de futbol” “inicie nuevamente en septiembre de este año me gane 9 , 10 millones” “perdí jugando 40 millones de pesos de un prestamos que me hizo Bancolombia” “tengo ansiedad, lloro, no puedo más”. “he tenido dos crisis de llorar”.
“el otro problema que tengo es el alcohol, cuando tomo no hay poder humano que me detenga, se me olvida mi familia, la camioneta, hace poco perdí los documentos” “con mi pareja hemos tenido demasiados conflictos”.

Enfermedad Actual

Paciente masculino que refiere malestar emocional persistente asociado a conflictos relacionales, antecedentes traumáticos y dificultades en la regulación emocional y autoestima. Relata que el embarazo de su primer hijo ocurrió en el contexto de una relación extramarital, situación que entró en conflicto con sus creencias familiares y valores personales aprendidos en su núcleo de origen, lo cual no ha logrado elaborar emocionalmente pese al tiempo transcurrido (aproximadamente 8 años). Posteriormente asumió la custodia del hijo, la cual mantiene hasta la actualidad.
Manifiesta sentimientos de culpa, arrepentimiento y pensamientos recurrentes de tipo contrafactual respecto a una relación previa significativa, con la cual existían planes de matrimonio. Durante dicha relación, la expareja presentó un aborto en contra de su voluntad, evento que el paciente identifica como emocionalmente significativo y no resuelto, posterior al cual fortaleció conductas de infidelidad.
Posteriormente estableció una relación de pareja actual, inicialmente percibida como positiva y contenedora, incluyendo una adecuada vinculación con su hijo. Refiere que tras el nacimiento de una hija —gestación planeada— se presentaron cambios en la dinámica familiar, especialmente un trato diferenciado hacia su hijo mayor, lo que generó conflicto y malestar. Describe discusiones frecuentes con su pareja, durante las cuales reconoce conductas verbales agresivas e insultos, seguidos de sentimientos de culpa y ambivalencia afectiva hacia ella. El paciente percibe a su pareja como controladora, refiriendo restricciones en su tiempo personal, relaciones familiares y sociales, lo que incrementa su irritabilidad y respuestas impulsivas. Refiere sensación de manipulación emocional y dificultad para establecer límites. Menciona que los antecedentes relacionales de su pareja y la crítica social asociada a estos han impactado negativamente su autoconcepto y bienestar emocional.
En el ámbito personal, el paciente presenta baja autoestima, autocrítica constante y dificultad para reconocer sus capacidades, pese a recibir retroalimentación positiva de su entorno respecto a su desempeño intelectual y profesional.
En los últimos dos meses reporta incremento en conductas de riesgo, incluyendo consumo de alcohol, apuestas y sobrecarga laboral mediante turnos adicionales en su ejercicio profesional como médico internista. Presenta antecedentes de crisis de pánico, caracterizadas por temor intenso a morir, especialmente al usar transporte público, con pensamientos anticipatorios persistentes. Refiere además un evento traumático significativo en junio de 2011, correspondiente a un accidente de tránsito en el cual fallecieron varias personas y hubo múltiples heridos, tras lo cual presentó sintomatología compatible con estrés postraumático.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

NO REFIERE

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

NO REFIERE

Patología

HIPERTENSIÓN

Tóxicos

NO REFIERE

Medicación

NO REFIERE

Hospitalizaciones

NO REFIERE

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad Madre
Demencia No Refiere	Alcoholismo Padre
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos DIABETES	Otros NEUMOPATIA POSTCOVID

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

Profesional en Medicina, egresado de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena. Durante su proceso formativo refiere adecuado desempeño académico y buenas relaciones interpersonales, describiéndose como una persona socialmente integrada, con habilidades sociales preservadas, actitud colaborativa y adecuada adaptación al entorno universitario.

Historia laboral

Actualmente se desempeña como médico internista desde hace aproximadamente dos años. Labora en el Hospital San Rafael de San Juan y en la Clínica Regional de Especialistas Sianis Vitaes. Refiere estabilidad laboral y ejercicio activo de su profesión, con carga asistencial elevada debido a la realización de turnos adicionales.

Historia familiar

Actualmente convive con su pareja, la Sra. Pierangelis Pabón, de 37 años de edad, quien cursa embarazo de 36.6 semanas, y con su hija Mia Celeste Catañeda, de 5 años. Refiere encontrarse en proceso de fortalecimiento de los lazos afectivos y de la dinámica familiar, reconociendo dificultades relacionales previas y ambivalencia emocional en el contexto de la convivencia actual. Como antecedente familiar relevante, refiere consumo problemático de alcohol por parte del padre, caracterizado por ingesta frecuente durante los fines de semana. No se reportan otros antecedentes psiquiátricos familiares significativos al momento de la evaluación.

Historia social

Refiere mantener buenas relaciones interpersonales, con estilo de personalidad extrovertido y adecuada adaptación social. Manifiesta recibir con frecuencia retroalimentación positiva por parte de su grupo de amigos, incluyendo críticas constructivas, palabras de ánimo y reconocimiento de sus habilidades y capacidades intelectuales. No obstante, el paciente expresa dificultad para interiorizar dichos comentarios positivos, evidenciando una autoevaluación negativa persistente, desconfianza en sus propias competencias y baja autovaloración, a pesar del reconocimiento externo. Reconoce intelectualmente poseer altas capacidades, pero refiere dudas recurrentes sobre su desempeño y sensación de no ser “tan bueno” como los demás perciben.

Historia socio-afectiva

El paciente se describe como una persona sociable, con disposición afectiva generalmente positiva y adecuada interacción social. No obstante, refiere la presencia persistente de pensamientos rumiativos asociados a culpa y arrepentimiento por eventos vitales pasados, los cuales generan malestar emocional significativo. Manifiesta utilizar el consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento para evadir o disminuir el impacto de dichos pensamientos, reconociendo que esta conducta resulta ineficaz y que posteriormente incrementa la sensación de malestar emocional. A pesar de lo anterior, se observa funcionalidad general conservada en las áreas personal, social y laboral. Sin embargo, el paciente refiere que los estados de ansiedad y culpa interfieren en su regulación emocional, incrementando la irritabilidad y el malestar psicológico, sin lograr una elaboración emocional adecuada de los eventos asociados.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se realizó evaluación psicológica inicial mediante entrevista clínica semiestructurada, orientada a la exploración de las diferentes áreas del funcionamiento personal, familiar, social y laboral del paciente. Asimismo, se empleó la técnica de observación directa para valorar la expresión emocional, el discurso, la actitud frente a la evaluación y la coherencia entre el relato verbal y la conducta observada.

Durante la sesión se utilizaron estrategias de diálogo socrático, así como técnicas de sensibilización y concienciación, orientadas a favorecer la identificación de patrones conductuales disfuncionales y la reflexión crítica sobre los síntomas referidos. Se brindó psicoeducación inicial acerca de la presencia de pensamientos distorsionados, así como sobre la gravedad y posibles consecuencias del comportamiento de juego patológico (ludopatía) y del consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento inadecuada.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

NO REFIERE

Intervención neurológica

NO REFIERE

Intervención neuropsicológica

NO REFIERE

Otras intervenciones

NO REFIERE

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

aciente ingresa a consulta con adecuado saludo y presentación personal acorde al contexto. Se observa alerta, consciente y orientado en las esferas autopsíquica y alopsíquica. Mantiene contacto visual adecuado y actitud amable y colaboradora durante la entrevista. El lenguaje es espontáneo, con contenido del discurso coherente, lógico y dirigido a la meta. No se evidencian alteraciones sensorioceptivas. La memoria impresiona conservada y la atención se encuentra sostenida durante la evaluación. El estado de ánimo se observa eutímico, con afecto congruente al discurso. Se encuentra consciente de los síntomas que presenta, con adecuado juicio de realidad e insight parcial conservado. Niega ideas e intentos suicidas. Se evidencia sufrimiento psicológico y manifestaciones de ansiedad durante la expresión verbal y en la postura corporal, sin comprometer el funcionamiento global durante la entrevista.

Ciclos del Sueño

CONSERVADOS

Apetito CONSERVADO
Actividades de Autocuidado CONSERVADAS E INDEPENDIENTE

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
Establecido por primera vez Si
Objeto de atención clínica La sintomatología actual del paciente se encuentra clínicamente asociada a cuadros compatibles con: 6C50.1 – Trastorno por juego de apuestas, predominantemente en línea, en evaluación, sin cumplimiento del criterio temporal mínimo requerido, evidenciándose conductas de riesgo de inicio reciente relacionadas con estados emocionales negativos. 6C40.10 – Patrón nocivo de consumo de alcohol, episódico, en evaluación, sin cumplimiento de criterios temporales para diagnóstico formal, identificado como estrategia de afrontamiento inadecuada ante ansiedad y rumiación cognitiva. 6B40 – Trastorno de estrés postraumático, en evaluación, considerando antecedente de evento traumático significativo y sintomatología ansiosa asociada, sin cumplimiento completo de los criterios temporales y clínicos al momento de la valoración. La presente formulación corresponde a una impresión diagnóstica inicial, sujeta a evolución clínica, seguimiento psicoterapéutico y valoración interdisciplinaria, no constituyendo diagnóstico definitivo.

PLAN DE INTERVENCIÓN
Plan de Intervención
Objetivo General Disminuir la sintomatología ansiosa y el malestar psicológico asociado a culpa, trauma no elaborado y conductas adictivas emergentes, favoreciendo el desarrollo de estrategias de afrontamiento adaptativas, regulación emocional y fortalecimiento del autoconcepto, manteniendo la funcionalidad personal, familiar y laboral del paciente.
Objetivos Específicos • Reducir la ansiedad y la rumiación cognitiva, mediante la identificación y reestructuración de pensamientos distorsionados asociados a culpa, autoexigencia y arrepentimiento. • Fortalecer la regulación emocional, promoviendo estrategias de afrontamiento saludables que sustituyan el consumo de alcohol y las conductas de juego como mecanismos de evasión. • Favorecer la elaboración emocional de eventos traumáticos, abordando progresivamente los antecedentes de estrés postraumático que influyen en el malestar actual. • Prevenir la progresión de conductas adictivas, a través de psicoeducación, sensibilización al riesgo y establecimiento de límites conductuales claros. • Fortalecer la autoestima y el autoconcepto, facilitando la integración del feedback positivo externo y disminuyendo la autocrítica persistente. • Promover habilidades de comunicación y establecimiento de límites, con el fin de reducir conflictos interpersonales y mejorar la dinámica familiar y de pareja.

Sugerencias e Interconsultas • Se sugiere Interconsulta con Psiquiatría, para valoración diagnóstica y posible manejo farmacológico, dada la presencia de sintomatología ansiosa persistente, antecedentes traumáticos y conductas adictivas emergentes. • Se considera pertinente interconsulta con Especialista o programa de atención en adicciones (Evaluación del nivel de riesgo, Intervención temprana en ludopatía y consumo problemático, Trabajo complementario al proceso psicoterapéutico). • Psicoterapia Individual por Psicología Clínica, 2 veces por semana 2 meses. • Se recomienda valoración por Medicina general/interna para seguimiento del estado de salud general y tamizaje por consumo de alcohol.
--

Observaciones y Recomendaciones OBSERVACIONES • Paciente con adecuado nivel de insight y disposición al proceso psicoterapéutico. • Funcionalidad personal, social y laboral globalmente conservada, pese a la presencia de malestar emocional significativo. • Sintomatología ansiosa activa asociada a rumiación cognitiva, culpa persistente y antecedentes traumáticos no elaborados. • Conductas de consumo de alcohol y juego identificadas como estrategias de afrontamiento inadecuadas, con riesgo de progresión. • Ausencia de ideación suicida activa al momento de la evaluación. RECOMENDACIONES • Se considera necesario seguimiento clínico continuo y abordaje interdisciplinario. • Disminuir y evitar el consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento; se sugiere monitoreo del consumo y psicoeducación continua. • Suspender conductas de juego/apuestas y establecer límites conductuales claros; considerar remisión a programa de adicciones según evolución clínica. • Implementar rutinas de autocuidado (higiene del sueño, actividad física, espacios de descanso, apoyo social y familiar). • Favorecer espacios de comunicación asertiva y establecimiento de límites en el contexto familiar y de pareja; considerar terapia de pareja o familiar a mediano plazo. • Reevaluar sintomatología ansiosa y conductas adictivas de forma periódica para ajustar el plan de tratamiento.
--

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542

